

# Guide d'administration

## Protocole *Cisplatine-Vinblastine (RTOG 94-10)*

Rédaction : Décembre 2002

Révisions : Octobre 2012, avril 2015, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

### 1. Application thérapeutique

---

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules, inopérable\*, de stade II ou III<sup>1, 2</sup>.

- › ECOG 0 ou 1
- › Perte de poids de  $\leq 5\%$  dans les trois derniers mois
- › Absence d'épanchement pleural (sauf si relié à une procédure)
- › Visée curative

\* Tumeur non résécable ou patients médicalement inopérables ou qui refusent la chirurgie.

### 2. Guide d'administration

---

#### 2.1. Description du protocole<sup>2</sup>

- › Le cisplatine est administré aux jours 1 et 29 de l'unique cycle de 5 semaines alors que la vinblastine est administrée aux semaines pendant les 5 semaines du cycle soit les jours 1, 8, 15, 22 et 29.
- › La radiothérapie est débutée au jour 1 du cycle.
- › En clinique externe.

## 2.2. Schéma d'administration<sup>2</sup>

| Ordre d'administration* | Médicament  | Dose                                                  | Description                                                                      |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #1                      | Vinblastine | 5 mg/ m <sup>2</sup> ,<br>jours 1, 8, 15,<br>22 et 29 | › IV soluté; dans 50 ml de NaCl 0.9 % en<br>5 à 10 minutes**                     |
| #2                      | Cisplatine  | 100 mg/m <sup>2</sup> ,<br>jours 1 et 29              | › IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9 % à<br>une vitesse maximale de 1 mg/min*** |

*Pour un cycle seulement*

\* Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole<sup>2</sup>

\*\* En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose ou de NaCl 0.9 % à haut débit pendant l'administration de la vinblastine (vésicant)<sup>2,5</sup>. Il est recommandé d'administrer la vinblastine dans un mini-sac pour prévenir l'administration fatale par voie intrathécale<sup>4</sup>.

\*\*\* Dans l'étude pivot, le cisplatine était administré en 30 à 60 minutes<sup>2</sup>. Il n'y a pas de consensus en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min<sup>3</sup>.

## 2.3. Thérapie de support

### › Hydratation<sup>5-8</sup>

- o S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- o Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- o Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- o Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure pendant 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure (on vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- o On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- o À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pendant 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- o Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- o Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoire.
- o En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- o Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

### › Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine<sup>9</sup>

- o L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4<sup>e</sup> et le 8<sup>e</sup> cycle, généralement après le 6<sup>e</sup> cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré (Voir [section 4.1. - Effets indésirables](#)).

Page 2 sur 10

› **Antiémétiques<sup>10</sup> :**

**Jours 1 et 29:** Potentiel hautement émétisant (>90 %)

**Antiémétiques pré-chimiothérapie**

| Pré-chimio | Antagoniste NK1                                   | Sétron   | Dexaméthasone | Olanzapine* |
|------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Option 1   | Aprépitant 125 mg PO                              | PO ou IV | 12 mg PO/IV   | 5-10 mg PO  |
| Option 2   | NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO |          | 12 mg PO/IV   | 5-10 mg PO  |

\* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1 et jour 29.

**Antiémétiques post-chimiothérapie**

| Post-chimio                                                               | Jour 2 et 30 | Jour 3 et 31 | Jour 4 et 32 | Commentaire                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| Aprépitant                                                                | 80 mg        | 80 mg        | ----         | Si utilisé en pré-chimio                 |
| Dexaméthasone                                                             | 8 mg         | 8 mg         | 8 mg         |                                          |
| Olanzapine                                                                | 5-10 mg      | 5-10 mg      | 5-10 mg      | Peut être donné au coucher si somnolence |
| Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements |              |              |              |                                          |

**Jours 8, 15, 22 :** Potentiel très faiblement émétisant (<10%)

- Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique.
- Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance du magnésium**

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine<sup>11</sup>. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3 à 4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé sur 4 heures<sup>12,13</sup>. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Surveillance de la mucosite<sup>2,14</sup>**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin.

› **Surveillance de la constipation<sup>15</sup> :**

- La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vinblastine.
- Prescription d'un laxatif et d'un agent émollient si besoin.

### 3. Guide d'ajustement posologique

#### 3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale<sup>3,15-17,19</sup>

| Médicament  | Ajustement posologique recommandé                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cisplatine  | Clcr entre 46-60 ml/min: 75 % de la dose<br>Clcr entre 31-45 ml/min: 50 % de la dose<br>Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine                              |
| Cisplatine  | Au jour 29: Si Clcr < 60 ml/min, retarder le cisplatine de 24 heures et hydrater agressivement. Administrer la dose au jour 30 selon l'ajustement ci-dessus. |
| Vinblastine | Aucun ajustement requis.                                                                                                                                     |

#### 3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique<sup>3,15,18.</sup>

| Médicament   | Ajustement posologique recommandé                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cisplatine   | Aucun ajustement requis.                                                                                                                               |
| Vinblastine* | Bilirubine entre 26 - 51 µmol/L: 50 % de la dose<br>Bilirubine entre 52 - 85 µmol/L: 25 % de la dose<br>Bilirubine > 85 µmol/L: omettre la vinblastine |

\*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

### 3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique<sup>19</sup>

| Jour de traitement                                                                         | Toxicité hématologique<br>(x 10 <sup>9</sup> /L)                                         | Ajustement posologique recommandé                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jour 1                                                                                     | Neutrophiles ≥ 1,5<br><b>et</b> plaquettes ≥ 100                                         | Pré-requis pour débiter le traitement.                                                                                                                                                                            |
| Jour 8, 15 et 22                                                                           | Neutrophiles ≥ 0,75<br><b>et</b> plaquettes ≥ 75                                         | Donner 100 % de la dose de vinblastine.<br>Si épisode antérieur de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 <sup>9</sup> /L, réduire la dose de vinblastine de 25 %.                                     |
|                                                                                            | Neutrophiles < 0,75<br><b>ou</b> plaquettes < 75                                         | Omettre la vinblastine.                                                                                                                                                                                           |
| Jour 29                                                                                    | Neutrophiles ≥ 1,5<br><b>et</b> plaquettes ≥ 100                                         | Donner 100 % de la dose de cisplatine et de vinblastine.<br>Si épisode antérieur de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 <sup>9</sup> /L, réduire les doses de cisplatine et de vinblastine de 25 %. |
|                                                                                            | Neutrophiles ≥ 1,0 - < 1,5<br><b>ou</b> plaquettes ≥ 75 - < 100                          | Donner 75 % de la dose de cisplatine et 100 % de la dose de vinblastine.<br>Si épisode antérieur de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 <sup>9</sup> /L, réduire la dose de vinblastine de 25 %.    |
|                                                                                            | Neutrophiles ≥ 0,5 - < 1,0<br><b>et</b> plaquettes ≥ 75                                  | Reporter le cisplatine au jour 36 et donner 50 % de la dose de vinblastine.                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Neutrophiles < 0,5 x 10 <sup>9</sup> /L<br><b>ou</b> plaquettes < 75 x10 <sup>9</sup> /L | Reporter le cisplatine et la vinblastine au jour 36.                                                                                                                                                              |
| Jour 36<br>(seulement lorsque doses de cisplatine ou de vinblastine du jour 29 non reçues) | Neutrophiles ≥ 1,0<br><b>et</b> plaquettes ≥ 75                                          | Donner 75 % de la dose de cisplatine et 100 % de la dose de vinblastine.<br>Si épisode de neutropénie fébrile et/ou neutrophiles < 0,5 x 10 <sup>9</sup> /L, réduire la dose de vinblastine de 25 %.              |
|                                                                                            | Neutrophiles ≥ 0,5 - < 1,0<br><b>et</b> plaquettes ≥ 75                                  | Omettre le cisplatine et donner 50 % de la dose de vinblastine.                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | Neutrophiles < 0,5<br><b>ou</b> plaquettes < 75                                          | Omettre le cisplatine et la vinblastine.                                                                                                                                                                          |

### 3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique<sup>adapté de 20</sup>

| Neurotoxicité                                                                                                                                               | Cisplatine                                                                                               | Vinblastine                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grade 2*<br>Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les AVQ).                       | Considérer administrer 50 - 75 % de la dose**.                                                           | Considérer administrer 50 -75 % de la dose** |
| Grade ≥ 3*<br>Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne.                                                        | Cesser le traitement                                                                                     | Cesser le traitement                         |
| Œsophagite                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                              |
| Grade ≥ 3*<br>Troubles sévères pour manger / déglutir ; nécessitant une sonde de nutrition entérale, une nutrition parentérale totale ou l'hospitalisation. | Ne pas ajuster les doses de chimiothérapie.<br>Réévaluer (interrompre) la radiothérapie ad amélioration. |                                              |

\* Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) - Version 4.0

\*\* Consensus d'experts

## 4. Monitoring

### 4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante (voir [section 3.3 - Guide d'ajustement posologique](#))<sup>2,19</sup>.

La **thrombocytopénie** est à surveiller car elle peut s'avérer sévère (voir [section 3.3 - Guide d'ajustement posologique](#))<sup>2,19</sup>.

Les **nausées** et **vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées et des vomissements de type retardés peuvent être présents et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie. La vinblastine a un potentiel émétique très faible et ne nécessite pas de prophylaxie (voir section [2.3 - Thérapie de support](#))<sup>10</sup>.

L'**œsophagite** est reliée surtout à la radiothérapie concomitante et peut entraîner son arrêt temporaire (voir section [3.4-Guide d'ajustement posologique](#))<sup>2,19</sup>.

La **mucosite** est un élément important à surveiller (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))<sup>2</sup>.

La **constipation** peut être sévère avec la vinblastine et peut même entraîner un iléus (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))<sup>20</sup>.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un

dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles<sup>23</sup>. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie<sup>22-24</sup>.

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible<sup>23</sup>. Une diminution de la vitesse de perfusion du cisplatine pourrait en diminuer l'incidence.

La **neuropathie périphérique** attribuable au cisplatine et à la vinblastine est lentement réversible et dans certains cas irréversible. Elle survient en fonction de la dose cumulative<sup>18, 20</sup>. La neurotoxicité associée à la vinblastine peut aussi se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides qui devrait être traitée avec des analgésiques sans ajustement la dose<sup>18</sup>.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administrées (voir section [2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve à l'adresse internet suivante; <http://www.geog.ca/pro/doc/291.pdf>. Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents<sup>9</sup>.

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine<sup>25</sup>.

L'alopecie est fréquente mais habituellement partielle<sup>3,26</sup>.

Le cisplatine est irritant pour les veines alors que la vinblastine est vésicante<sup>4</sup>.

**Tableau des effets indésirables<sup>2</sup>**

| Effets indésirables<br>(n= 193) | Grade 3*<br>(%) | Grade 4*<br>(%) | Grade 5*<br>(%) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leucopénie                      | 33              | 49              | 2               |
| Granulocytopénie                | 21              | 59              | 2               |
| Anémie                          | 10              | 2               | 0               |
| Thrombocytopénie                | 6               | 3               | <1              |
| Oesophagite                     | 21              | 2               | 0               |
| Nausée/vomissement              | 19              | 4               | <1              |
| Mucosite                        | 11              | 0               | 0               |
| Pulmonaire                      | 3               | <1              | 0               |
| Cardiaque                       | 0               | 0               | <1              |

\* Critères de toxicité du NCI version non spécifiée.

#### **4.2. Interactions cliniquement significatives<sup>3,15,18,26</sup>**

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP 450.

La **vinblastine** est un substrat majeur du CYP450 3A4, mineur du CYP450 2D6 et est également substrat de la glycoprotéine-P. C'est également un faible inhibiteur des CYP 450 2D6 et 3A4 ainsi qu'un inducteur de la glycoprotéine-P.

## Interactions cliniquement significatives

| Interactions avec le<br><b>Cisplatine</b> <sup>3, 15, 18</sup>                                                                         | Effet                                                                                                                                                     | Conduite suggérée                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anticonvulsivants</b><br>(p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)                                                     | ↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme.<br><i>Sévérité : modérée</i> | Utiliser avec prudence.<br>Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.                    |
| <b>Médicaments néphrotoxiques</b><br>(p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.) | ↑ du risque de néphrotoxicité.<br><i>Sévérité : modérée</i>                                                                                               | Éviter la co-administration.<br><br>Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine. |
| <b>Diurétiques de l'anse</b><br>(p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)                                                  | ↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                                                | Utiliser avec prudence.<br>L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.                                  |
| Lithium                                                                                                                                | ↓ des concentrations sériques du lithium.<br><i>Sévérité : modérée</i>                                                                                    | Utiliser avec prudence.<br>Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.                        |
| Vaccins vivants                                                                                                                        | Risque d'infection.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                                                                          | Contre-indiqué.                                                                                                                          |
| Warfarine                                                                                                                              | ↑ du RNI et du risque de saignement.<br><i>Sévérité : modérée</i>                                                                                         | Utiliser avec prudence.<br>Surveiller le RNI étroitement.<br>Surveiller l'apparition de signes de saignement.                            |
| Interactions avec la<br><b>Vinblastine</b> <sup>3,15,26</sup>                                                                          | Effet                                                                                                                                                     | Conduite suggérée                                                                                                                        |
| <b>Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4</b> (p. ex. : kétocozazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, etc.)                  | ↑ des concentrations de vinblastine.<br><i>Sévérité : Majeure</i>                                                                                         | Éviter la co-administration.                                                                                                             |
| <b>Inducteurs puissants du CYP 450 3A4</b><br>(p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)                      | ↓ des concentrations de vinblastine.<br><i>Sévérité : Majeure</i>                                                                                         | Éviter la co-administration.                                                                                                             |
| <b>Inhibiteurs de la glycoprotéine-P</b><br>(p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)                    | ↑ des concentrations de vinblastine.<br><i>Sévérité : Majeure</i>                                                                                         | Éviter la co-administration.                                                                                                             |



|                                                                                                                |                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Inducteurs de la glycoprotéine-P</b><br>(p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.) | ↓ des concentrations de vinblastine.<br><br><i>Sévérité : Majeure</i>                      | Éviter la co-administration. |
| <b>Substrats de la glycoprotéine-P</b><br>(p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)      | ↓ des concentrations des substrats de la glycoprotéine-P.<br><br><i>Sévérité : majeure</i> | Utiliser avec prudence.      |
| Vaccins vivants                                                                                                | Risque de développer une infection.<br><br><i>Sévérité : majeure</i>                       | Éviter la co-administration. |

#### 4.3. Suivi de laboratoire

|                         | Labos pour ajustements des doses                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilan de BASE           | Audiogramme<br>FSC, urée, créatinine, électrolytes, magnésium, bilan hépatique                            |
| Aux semaines            | Maximum 24 heures avant le traitement:<br>FSC, urée, créatinine, électrolytes, magnésium, bilan hépatique |
| Si cliniquement indiqué | Audiogramme                                                                                               |

## 5. Références

1. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi - Cancer du poumon. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger, Stéphanie Goulet et Marie-Christine Paquin. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2014; 269p.
2. Curran WJ, Paulus R, Langer CJ, Komaki R, Lee JS, Hauser S et coll. Séquentiel vs concurrent chemoradiation for stage III non-small cell lung cancer: randomized phase III trial RTOG 9410. J Natl Cancer Inst. 2011;103: 1452-1460.
3. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 25 janvier 2015.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p.
5. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. Ann Pharmacother 2012;46:276-81.
6. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et coll. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial. Cancer Chemother Pharmacol 2003;52: 13-18.
7. Leu L, Baribeault D. A comparison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventative measure. J Oncol Pharm Practice 2010;16: 167-171.
8. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et coll. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. Cancer Chemother Pharmacol 2008;61: 903-909.

9. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013.
10. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : [https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS\\_Antiemetiques.pdf](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf)
11. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25: 47-58.
12. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A, et coll. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4): 348-351.
13. Magnesium. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 15 février 2015).
14. Lalla RV, Bowen J, Barasch A, et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014;120: 1453-61.
15. Bragalone DL, Dana WJ, Edwards MS, et coll. Drug Information Handbook for Oncology, 10th ed. Hudson: Lexi-Comp Inc, 2012.
16. Aronoff GR, Bennett WM, Bems JS et al. Drug prescribing in renal failure: Dosing guidelines for adults and children, 5th ed. Philadelphia: American College of Physicians, 2007.
17. Kintzel PE et Dorr RT. Anticancer drug renal toxicity and elimination: Dosing guidelines for altered renal function. *Cancer Treat Rev* 1995;21(1):33-64.
18. Cisplatin. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 21 février 2015).
19. Radiation therapy oncology group. A three-arm phase III study of concomitant versus sequential chemotherapy and thoracic radiotherapy for patients with locally advanced inoperable non-small cell lung cancer (RTOG 94-10) <http://www.rtog.org> (consulté en ligne le 26 janvier 2015).
20. APhC. Monographie de la vinblastine. e-CPS (consulté en ligne le 21 février 2015).
21. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993;50:147-58.
22. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993;27:1519-25.
23. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5):368-79.
24. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
25. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <https://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté en ligne le 21 février 2015).
26. Vinblastine. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible au: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 21 février 2015).